

(2025). Asymmetric intraocular pressure changes in dominant and contralateral eyes: the dark room prone provocative test. *Seminars in Ophthalmology*, 40(4), 325-331. <https://doi.org/10.1080/08820538.2024.2443972>

- 备注：定 B 的原因有两条。一是武汉那两组是翻旧病历比出来的，封控本身还带来别的差别，和「拖延」这一项分不开。二是韩国那组只有 50 只眼，也是回顾性的。诱因说的不是看屏幕，是两件事叠在一起：暗处瞳孔会散大，长时间低头或者趴着又把晶状体往前顶。前房本来就浅的人容易被这样诱发，所以真正高危的是 50 岁以上、远视、家里有人得过闭角型青光眼的人。年轻人通宵打游戏基本不会这样发作。发作时最常见的错判是当成胃肠炎、偏头痛或者血压高，因为头痛呕吐比眼睛的症状更抢眼。不疼不红的单眼看不见是另一回事，见第 5 条（一只眼睛突然黑掉）。防蓝光眼镜有没有用，见第 6 节第 16 条（防蓝光眼镜）。

7. 胸口压着疼、闷、发紧超过 15 分钟不缓解，打 120，不要自己扛也不要自己开车

- 成本：不花钱。
- 说人话：胸口压着疼、闷、发紧，超过 15 分钟不缓解，打 120。到医院后 55 分钟内把血管撑开的，30 天内死亡 2.8%。超过 55 分钟的 9.7%。耽误的每一分钟，都在多坏死一块心肌。别自己开车，路上失去意识就是第二场事故。
- 收益：以色列做过一项全国急性冠脉综合征调查。分析的对象是 ST 段抬高心肌梗死患者，这是一类心梗。算的是从进医院到用球囊把堵住的血管撑开（球囊扩张）这一段间隔。间隔 ≤ 55 分钟的，30 天内死亡 5/178（2.8%）。间隔 > 55 分钟的，30 天内死亡 15/155（9.7%）
- 证据等级：B
- 来源：Karkabi B, Meir G, Zafirir B, et al. (2021). Door-to-balloon time and mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. *European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes*. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa037>
- 备注：该研究比的是进了医院之后耽误的那段，不是从发病到进医院那段。但道理一样：每耽误一会儿，就多坏死一块心肌。疼可能疼在上腹、后背、下巴，也可能是左胳膊发麻。糖尿病人和老年人可能不疼，只是喘。不要自己开车，路上失去意识就是第二场事故

8. 突然像被撕开一样的剧痛，从胸口往后背、往腰一路挪，打 120 并说清「疼在移动」

- 成本：不花钱。
- 说人话：撕裂一样的剧痛从胸口往后背、往腰一路挪，打 120 时直接说「像撕开一样，疼在往下走」。这病不手术、光吃药的死亡率 58%。它的处理和心梗正相反：医生想到它，才会去做增强 CT，而不是给你抗凝溶栓。两条胳膊血压差很多、一侧摸不到脉，也一起说出来。
- 收益：国际急性主动脉夹层登记（IRAD）收了 12 家中心的 464 例。主动脉夹层就是胸背撕裂样剧痛那种病。病人最先说出来的症状里，最常见的是突然发作的剧烈锐痛。住院期间总死亡率 27.4%。A 型夹层没做手术、只吃药的，死亡率 58%
- 证据等级：B
- 来源：Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. (2000). The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. *JAMA*, 283(7), 897-903. <https://doi.org/10.1001/jama.283.7.897>
- 备注：夹层和心梗的处理正好相反。心梗要用抗凝、溶栓这类让血别凝住的药，用在夹层上等于给撕口放血。所以到医院要主动说「撕裂样，疼在往下走」，让医生想到查增强 CT。两条胳膊血压差很多、一侧摸不到脉搏，是提示。血压控制不好的、有马凡综合征的、家里得过主动脉瘤或者夹层的，风险高。同样不要自己开车，不要忍到第二天

9. 突然一记「这辈子最疼的头痛」，一小时内就到最疼，立刻去急诊做头颅 CT

- 成本：看急诊本身不花什么钱。急诊做一次头颅 CT 几百元。

- 说人话：要看的是多快疼到最厉害。一小时内疼到顶的剧烈头痛，约 6% 是脑表面的血管破了。40 岁以上、脖子痛或发硬、有人看到你晕过去、活动中起病、瞬间炸开、脖子往前低不下去，中一条就去急诊做头颅 CT。去查的人大多没事，但漏一次再出血就是死亡。
- 收益：加拿大 10 家急诊对 2131 例「一小时内达到最痛的剧烈头痛」做了前瞻队列研究，事先定好标准，再一路跟踪记录。其中 132 例（6.2%）是蛛网膜下腔出血（脑表面的血管破了）。渥太华 SAH 规则有六条：40 岁及以上、脖子痛或者发硬、有人看到晕过去。另外三条是活动中发作、一下子炸开式发作、医生查体时脖子前屈受限。符合任一条就要查。这条规则把出血的人全都挑了出来，敏感性 100%，95% CI 97.2%–100.0%（可信范围）。代价是没出血的人里只有 15.3% 被它排除掉（特异性 15.3%）
- 证据等级：A
- 来源：Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti MLA, et al. (2013). Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. JAMA, 310(12), 1248-1255. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.278018>
- 备注：要看的不是「有多疼」，是「多快到最疼」，几秒到一分钟内炸开的头痛才是危险信号，慢慢加重的偏头痛不是。伴呕吐、脖子发硬、怕光、短暂晕厥，更要当回事。特异性只有 15.3%，意思是按这条去查的人绝大多数查完没事。但漏掉一次再出血就是死亡，值得查。不要吃片止痛药压下去接着睡

10. 老人磕过头之后两三周到几个月变得走路不稳、迟钝、嗜睡或者一侧没劲，去做头颅 CT

- 成本：做一次头颅 CT 两三百元。
- 说人话：老人磕头之后，血通常到第三周才积起来。撞的当时可以完全没事，人自己都想不起磕过。这病开刀之后复发率能到 33%，病死率能到 32%。发现老人突然糊涂、走路发飘、总想睡、一只手没劲，先倒回去问这两三个月摔没摔过头，再去做 CT。
- 收益：中华医学会神经外科学分会等发布过《慢性硬膜下血肿药物治疗中国专家共识》。慢性硬膜下血肿，是脑膜之间慢慢积起来的一摊血。专业说法是蛛网膜与硬脑膜之间积血形成的慢性占位。它「通常在颅脑外伤后第三周形成」，多见于老年人。开刀之后复发率可达 33%，病死率可达 32%。90 岁以上的病人，总体上恢复得好的只有 24%。系统综述：全球每 10 万人每年新发 3.39 到 39.1 例，随年龄升高，80 岁以上可达三倍。最常见的起因是外伤和跌倒，其次是长期酗酒、用防止血液凝固的药（抗凝）和暴力伤害。老年医学综述：临床表现「典型包括意识模糊、认知下降、步态障碍或嗜睡，可能与其他老年综合征相似」
- 证据等级：B
- 来源：Zhang J 等 (2021). Expert consensus on drug treatment of chronic subdural hematoma. Chinese Neurosurgical Journal, 7(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s41016-021-00263-z> ; Dziho A 等 (2025). Global prevalence and incidence of chronic subdural hematoma: A systematic review. Brain and Spine, 5, 105893. <https://doi.org/10.1016/j.bas.2025.105893> ; Mathon B, Shotar E (2026). Diagnostic and therapeutic management of chronic subdural hematoma in elderly patients. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillessement, 24(1), 30-41. <https://doi.org/10.1684/pnv.2026.1274>
- 备注：撞的时候可以完全没事，老人自己甚至想不起磕过。所以家里发现「最近突然糊涂了、走路发飘、总想睡、一只手没劲」，先倒回去问这两三个月有没有摔过、撞过头，再去做 CT。别直接归到「老年痴呆」或者「上次中风的后遗症」上，归错了就会耽误。吃阿司匹林、氯吡格雷、华法林或者新型口服抗凝药的老人，风险更高，长期大量喝酒也是。防跌倒见第 1 节第 13 条（练平衡和腿部力量）。

11. 一条腿突然肿起来、发紧、按着疼，尽快就医；再加上突然喘不上气或者胸痛，立刻打 120

- 成本：腿部血管做一次超声（下肢静脉超声），一两百元。

- 说人话：一条腿突然肿起来、比另一条粗一圈、按着疼，尽快去做腿部静脉超声。再出现突然喘不上气、深吸气时胸痛、心跳快、发晕，血块可能已经跑到肺里，直接打 120。确诊肺栓塞的人 3 个月内死亡 17.4%。久坐超过 4 小时风险大约翻倍，但摊到一个人头上仍然很低。
- 收益：国际肺栓塞协作登记（ICOPER）收了 7 个国家 52 家医院的 2454 例确诊急性肺栓塞病人。肺栓塞就是血块堵住肺动脉。这批人 3 个月内不分原因的死亡率是 17.4%（426/2454）。世界卫生组织 WRIGHT 项目：连续 4 小时以上的旅行，让静脉里长血块、血块跑到肺里（静脉血栓栓塞）的风险「大约翻倍」。但摊到一个人头上的概率仍然很低，久坐不动超过 4 小时「约为六千分之一」
- 证据等级：B
- 来源：Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M (1999). Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). *Lancet*, 353(9162), 1386-1389. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(98\)07534-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07534-5) ; WHO (2007). Study results released on travel and blood clots. <https://www.who.int/news/item/29-06-2007-study-results-released-on-travel-and-blood-clots>
- 备注：两条腿一起肿，多半是心、肝、肾或者静脉功能的问题。一条腿突然肿、比另一条粗一圈，才是深静脉血栓的典型样子。容易出事的是长途坐车坐飞机、手术或骨折后卧床、打石膏、怀孕生产前后、肿瘤、吃口服避孕药。血块脱落、堵住肺动脉就是肺栓塞：突然喘不上气、深吸一口气胸口更疼、心跳快、发晕、咳出血（咯血）。到这一步直接打 120。17.4% 是确诊肺栓塞病例的死亡率，不是「腿肿了就有这么大风险」，别对着这个数字吓自己。

12. 大出血先用手死死压住伤口，四肢压不住就上止血带，同时打 120

- 成本：一根旋压式止血带几十到一百多元，放车里和急救包里。学一次「扎在伤口上方、拧到血停、记时间」，几分钟。
- 说人话：先用手或衣物死死压住，四肢压不住就上止血带，再打 120，上了就不松开。战地伤员里，休克前上止血带的活了九成，休克后才上的只活一成，该上没上的 5 个人全死了。扎在伤口上方，拧到血停，记下时间。别拿鞋带绳子代替。脖子和躯干只能压，不能扎。
- 收益：美国得州 11 家一级创伤中心 6 年里收了 1,026 例四肢血管伤，其中 181 例（17.6%）在到医院之前上了止血带。不做任何调整直接算，上了止血带的死亡 3.9%，没上的 5.2%。把其他条件拉平之后（多因素校正），上止血带仍然单独和活下来相关。校正 OR 5.86，可信范围是 95% CI 1.41 到 24.47。巴格达战地医院的 232 名伤员：休克出现前上止血带的存活 90%，休克后才上的只有 10%。需要止血带而没上的 5 人全部死亡，上了的存活 87%。顺序是：直接压迫，衣物、毛巾都行 → 压不住的四肢出血上止血带 → 打 120 → 不松开
- 证据等级：A
- 来源：Teixeira PGR 等 (2018). Civilian Prehospital Tourniquet Use Is Associated with Improved Survival in Patients with Peripheral Vascular Injury. *Journal of the American College of Surgeons*. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2018.01.047> ; Kragh JF 等 (2009). Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. *Annals of Surgery*. <https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818842ba> ; 中国医师协会急诊医师分会等 (2020). 止血带的急诊应用专家共识. *中华急诊医学杂志* 29(6):773-779:「院前急救时，止血带一旦使用则不建议松开，除非得到可以替代的彻底止血的救治」「最长使用时间不应超过 2 h。但如果客观情况无法到医院救治或者无替代止血办法，则在得到正规救援前不解除止血带」. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.06.006>, 全文 <http://www.cem.org.cn/rhtml/20200606/index.htm>
- 备注：不要拿绳子、鞋带这类细东西当止血带，勒不住动脉，还割破皮肤。上了止血带不要隔一会儿松一下「放放血」。脖子和躯干上的出血只能压，不能扎。那份战地数据里，止血带本身没有让谁截肢，出现短暂神经麻痹的有 4 例。中国急诊医师的专家共识说法一致：院前一旦用上就不建议松开，除非有别的办法能彻底止血。上臂出血扎在上臂中上三分之一，大腿出血扎在大腿根。前臂、小腿、肘、膝上不要扎。共识建议到医院前后总共尽量别超过 2 小时，但到不了医院、又没别

的办法止血的，等到正规救援之前不解开。皮带、领带、衣袖临时做的止血带，单用很难止住血，要配一根棍子绞紧。

13. 被狗、猫咬伤或抓破皮，先用肥皂水和流水交替冲 15 分钟，当天去打疫苗

- 成本：冲洗不花钱。狂犬病疫苗全程几百元。三级暴露还要加打狂犬病被动免疫制剂（直接打进现成的抗体），几百到上千元。
- 说人话：狂犬病一旦发病，病死率几乎 100%，冲洗加疫苗是唯一的路。先用肥皂水和流动清水交替冲 15 分钟，当天去打疫苗。咬穿了、破皮的地方被舔，属于三级暴露，还要加打被动免疫制剂。「家养的、打过针的」不改变处置，级别按伤口定，不按狗的来历定。
- 收益：国家疾控局、国家卫健委 2023 年版规范原文：「狂犬病病死率几乎达 100%」。处置是「用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处约 15 分钟」。裸露皮肤被轻咬、无出血抓伤，是 II 级暴露，要打疫苗。贯穿性咬伤、破损皮肤被舔，是 III 级暴露，「应处置伤口并注射狂犬病被动免疫制剂和接种狂犬病疫苗」。WHO：全球每年约 5.9 万人死于狂犬病，99% 由狗传播
- 证据等级：A
- 来源：国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅 (2023). 关于印发狂犬病暴露预防处置工作规范（2023 年版）的通知. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1706569159854649344.html ; WHO. 狂犬病 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/rabies>
- 备注：不要因为「家养的、打过针的」就不处理。规范看的是伤口到了哪一级（暴露级别），不看狗的来历。不要自己包伤口。十日观察法只能决定要不要停针，不能决定要不要开始打。被野生动物、蝙蝠咬伤，同样这么处理。

14. 烫伤后立刻用凉的流动水冲 20 分钟，别抹牙膏酱油

- 成本：不花钱。占 20 分钟。
- 说人话：受伤 3 小时内用凉的流动水冲够 20 分钟，后来需要植皮的可能性大约只有没冲的六成。是凉水不是冰水，冰敷会加重损伤。衣服粘在伤口上别硬撕，冲完拿干净布盖住去医院。牙膏、酱油、香油、面粉都不要抹。隔了一会儿才想起来，三小时内补冲仍然有用。
- 收益：澳大利亚跟踪了 2495 名烧烫伤儿童。受伤后 3 小时内用凉流动水冲 20 分钟的孩子，后来需要植皮的比值比是 0.6，95% CI 0.4–0.8（可信范围），大约只有没这么冲的六成。7 项研究合起来算的结果同样发现，「伤后三小时内 20 分钟凉流动水显著降低了需要植皮和手术处理创面的可能」
- 证据等级：A
- 来源：Griffin BR, Frear CC, Babl F, Oakley E, Kimble RM (2020). Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children. *Annals of Emergency Medicine*, 75(1), 75-85. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2019.06.028>; Griffin B, Cabilan CJ, Ayoub B, et al. (2022). The effect of 20 minutes of cool running water first aid within three hours of thermal burn injury on patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Australasian Emergency Care*, 25(4), 367-376. <https://doi.org/10.1016/j.auec.2022.05.004>
- 备注：是凉水不是冰水，冰敷会加重损伤。衣服粘在伤口上就别硬撕，冲完用干净布盖住去医院。牙膏、酱油、香油、面粉都不要抹，会影响医生判断深度，还容易感染。三小时内补冲仍然有用

15. 突然全身起疹、喘不上气或者发晕，按过敏性休克处理，立刻叫 120 并说清楚

- 成本：不花钱。已知有严重过敏的人自备肾上腺素笔要花钱，而且它是处方药。
- 说人话：突然全身起疹，再加上喘不上气或者发晕，就按过敏性休克办。立刻打 120，直接说「怀疑过敏性休克」，让急救带着肾上腺素来。抗过敏药和激素起效慢，替不了肾上腺素。有过一次的人找医生开自动注射笔，打大腿中外侧，隔着裤子也能打。
- 收益：肾上腺素是二级及以上过敏性休克首选的药（一线药），指南把它列为强推荐。抗过敏药和激素起效慢，顶不了它的位置

- 证据等级：B（指南强推荐，但底层证据等级低）
- 来源：中国医药教育协会等 (2022). 过敏性休克急救临床实践指南（2020）. *Frontiers in Pharmacology*: 「Epinephrine is the first-line medicine in GRADE II to IV anaphylaxis」 「Intramuscular epinephrine should be injected in the mid-anterolateral thigh」，成人肌注上限 0.5 mg、14 岁以下 0.3 mg，无反应可每 5–15 分钟重复一次. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.845689>；Muraro A, et al. (2022). EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). *Allergy*. <https://doi.org/10.1111/all.15032>
- 备注：这份过敏指南（EAACI）自己写明，这个领域「证据大多停留在很低的等级」。它列为强推荐，是因为好处远大于风险，不是因为有大型试验。肾上腺素在国内是处方药，普通人手上通常没有。能做的是叫 120，并说「怀疑过敏性休克」，让急救带着药来。有过一次严重过敏的，找医生开自动注射笔，学会打大腿中外侧（外侧偏前），隔着裤子也能打。

16. 有人抽搐倒地，清开周围、让他侧躺、看表计时，什么都别往嘴里塞

- 成本：不花钱。
- 说人话：把周围的硬东西挪开，让他侧躺、嘴朝下，看表记时间。别按住他，别掰嘴，别往嘴里塞东西，那只会弄伤牙齿和下颌。超过 5 分钟不停、停了很快又发作、发作后叫不醒或者呼吸困难、在水里发作、这是头一次发作，都要叫救护车。等人完全清醒再给水。
- 收益：避免掰嘴、塞硬物造成的牙齿和下颌损伤。避免强行按住造成的骨折。超过 5 分钟不停，是必须叫救护车的红线
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 癫痫发作急救：「Don't hold the person down or stop their movements」 「Don't put anything in their mouth. This can hurt their teeth or jaw」 「Don't offer water or food until they are fully alert」 「Time the seizure to track if it lasts more than 5 minutes. If it does, seek immediate medical attention or call 911」. <https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html>
- 备注：同一页还列了另外几种要立刻叫救护车的情况：一次结束后很快又发作、发作后叫不醒或者呼吸困难、发作中受了伤、在水里发作、这是第一次发作。发作停了让他侧躺、嘴朝下，等人完全清醒再给水。家里有癫痫病人的，这套动作最用得上。对陌生人做同样的动作，好处回到你身上的机会小一些，但也不会让你担责（民法典第一百八十四条，见本节第 2 条，别急着把人扶起来）。

17. 糖尿病人突然发抖、出冷汗、说话不清，先给 15 克糖，15 分钟后复测

- 成本：不花钱。随身带几块方糖或者一小盒果汁。
- 说人话：先吃 15 克糖，方糖、一小盒果汁都行。15 分钟后再测一次，还低就再来一次。血糖低于 3.0 mmol/L 就是医学上要当回事的低血糖。到了要别人帮忙才能处理的程度，可以致命。意识不清的人一口都别喂，会呛进气管，直接打 120。
- 收益：血糖低于 3.0 mmol/L，属于临床上有意义的低血糖。出现意识或者行动改变、需要别人帮忙处理的，是重度低血糖，可以致命
- 证据等级：A
- 来源：美国糖尿病学会 (2025). 糖尿病诊疗标准 2025·第 6 章 血糖目标与低血糖. *Diabetes Care*: 分级「Level 1: Glucose <70 mg/dL (<3.9 mmol/L) and ≥54 mg/dL (≥3.0 mmol/L)」 「Level 2: Glucose <54 mg/dL (<3.0 mmol/L)」 「Level 3: A severe event characterized by altered mental and/or physical status requiring assistance for treatment of hypoglycemia, irrespective of glucose level」；处理「For most individuals, 15 g carbohydrates should be ingested」 「Fifteen minutes after initial treatment, repeat the treatment if hypoglycemia persists」. <https://doi.org/10.2337/dc25-S006>
- 备注：意识不清的人不要喂东西，会呛进气管，直接叫 120。同一份标准还建议，打胰岛素的人、容易低血糖的人，都该备一份胰高血糖素。原文是「All individuals treated with insulin or who are at high risk of hypoglycemia...should be prescribed glucagon」。鼻喷的和事先装好药的针剂，比要临时兑药的好用。这些做法默认是给你自己或者家里的糖尿病人准备的，随身带糖也是给他们带的。

18. 有人触电，先断电，再用干燥的木棍之类挑开电源，不要直接上手拉

- 成本：不花钱。
- 说人话：先断电，或者用干燥的木棍之类把电源挑开，再碰人。直接上手拉，一个伤者就变成两个。脱离电源后没有呼吸的，立刻按第 1 条（用力按压胸口）按压，别因为是电伤就不敢碰。高压线落地、变电设备附近不自己处置，退远等电力部门断电。
- 收益：避免施救的人一起被电住，把一个伤者变成两个。脱离电源后没有呼吸的，按本节第 1 条（用力按压胸口）做心肺复苏。美国疾控中心的急救步骤是：先看，别碰，人可能还连着电。能断电先断电，断不了就用纸板、塑料或木头这类不导电的东西把电源拨开。脱离电源后，呼吸或脉搏停了的，立刻做心肺复苏。一篇综述说，触电后心跳骤停、被救回来的人，预后往往不错
- 证据等级：B
- 来源：US CDC. What to Do to Protect Yourself From Electrical Hazards (First aid 一节) . <https://www.cdc.gov/natural-disasters/response/what-to-do-protect-yourself-from-electrical-hazards.html>; Spies C, Trohman RG (2006). Narrative review: Electrocution and life-threatening electrical injuries. *Annals of Internal Medicine* 145(7):531-537. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-7-200610030-00011>
- 备注：「先断电再碰人」是纯自利规则：直接上手拉，倒下的第二个就是你。高压线落地、变电设备附近不要自己处置，退远等电力部门断电。触电引起的心脏骤停，照常规按压、照常规除颤就行，别因为是「电伤」就不敢上手。

19. 一氧化碳报警器响了，或者一屋子人同时头痛恶心，先出门再打电话

- 成本：不花钱。
- 说人话：报警器响了，或者一屋子人同时头痛、恶心、发晕，先把人都带到室外，再打电话。别留在屋里找原因，也别回去关阀门。症状像感冒，「出门就好转」是最强的提示。中国 2018 年报告了 11523 人死于一氧化碳中毒，冬天最多，大多死在家里。
- 收益：中国疾控的死因监测系统 2018 年报告了 11523 例一氧化碳中毒死亡。最多的是 1 月（2845 例）、2 月（2321 例）和 12 月（2010 例）。冬天这三个月，死在家里的占 66% 到 73%。这是系统里报上来的数，不是按全国人口推算的。美国每年 400 多人死于与火灾无关的意外一氧化碳中毒。10 万人以上进急诊，1.4 万人以上住院
- 证据等级：B
- 来源：You J, Liu J, Zhou M (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death – China, 2018. *China CDC Weekly* 2(2):32: 「In 2018, there were 11,523 deaths caused by carbon monoxide poisoning reported in China」. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008>; 美国疾病控制与预防中心. 一氧化碳中毒：「More than 400 Americans die from unintentional CO poisoning not linked to fires」 「More than 100,000 visit an emergency department」 「More than 14,000 are hospitalized」, 常见症状「headache, dizziness, weakness, upset stomach, vomiting, chest pain, and confusion」. <https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html>; 美国消费品安全委员会. 一氧化碳信息中心：「If you suspect CO poisoning, get outside to fresh air immediately, and then call 911」. <https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Carbon-Monoxide-Information-Center>
- 备注：症状像感冒，又像喝多了。一屋子人一起难受、出门就好转，是最强的提示。别留在屋里找原因，别回去关阀门，人先出来再打电话。报警器怎么装见第 1 节第 3 条。

20. 误服清洁剂、农药、药物先别催吐，带上瓶子立刻就医；溅到眼睛或皮肤用大量清水至少冲 15 分钟

- 成本：不花钱。把清洁剂、消毒液、农药和药品放到孩子够不着的高处，或者带锁的柜子里。绝不分装进饮料瓶。
- 说人话：误服清洁剂、农药、药物不要催吐，腐蚀性液体吐出来会把食管再烧一遍。先喝适量牛奶或者蛋清，带上瓶子和说明书立刻去医院。溅到皮肤或者眼睛，用大量清水至少冲 15 分钟，眼睛要撑开眼皮冲、不要揉。消毒液和洁厕剂混着用会产生氯气。

- 收益：中国疾控中心职业卫生与中毒控制所给的处置口径分四种。吃进嘴里（消化道摄入）的，立即饮用适量的牛奶或蛋清，「切记，不要催吐」。尽快就医，同时携带包装或说明书，「以便于医生快速判断成分并制定救治方案」。吸进气里（呼吸道吸入）：立即转移至通风良好的区域，解开衣领保持呼吸通畅；出现剧烈咳嗽、气促或呼吸困难的，立即就医。皮肤接触：立即用大量清水冲洗接触部位至少 15 分钟，注意别让冲洗液溅到眼睛或者其他完好皮肤。眼睛接触的，立即用大量清水或生理盐水冲洗眼睛至少 15 分钟。冲洗时撑开眼睑，让水流充分接触眼球及眼睑内侧，「切勿揉搓眼睛」。冲洗后立即前往眼科。高危产品按酸碱度（pH）认。pH<3 的是洁厕剂、除垢剂、地板清洁剂、不锈钢光亮剂。部分强力管道疏通剂还含稀硫酸。pH>11 的是管道疏通剂、厨房强力除污剂、洗碗粉、爆炸盐、去污粉。还有一个当场出事的组合：消毒液和含盐酸的洁厕剂一起用会产生氯气，刺激呼吸道、引起剧烈咳嗽和气促，甚至危及生命
- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕强酸强碱清洁剂. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm
- 备注：定 B 是因为官方科普只讲了该怎么处理、怎么认出来，没有「照做能少出多少事」的数字。不催吐的道理是：腐蚀性的液体吐出来，会把食管（嗓子到胃那根管子）再烧一遍。拿不准误服的是什么，就把瓶子、说明书连同呕吐物一起带去医院。预防比急救便宜得多：分类存放，别和食物饮料混放，用完拧紧盖子扔掉空瓶，绝不倒进矿泉水瓶。使用时戴橡胶手套和护目镜，开窗通风，不同类型不混用。一氧化碳见第 19 条，烧烫伤见第 14 条。酸碱这类化学品溅到身上，怎么脱衣服、冲多久，见第 21 条（化学品溅到身上）。

21. 酸碱等化学品溅到身上，立刻脱掉污染的衣服、用大量流动清水冲，眼睛要掰开眼皮冲，冲够时间再走

- 成本：不花钱。上岗第一天就把洗眼器和冲淋装置的位置看好，别等出事再找。
- 说人话：三步。第一步，立刻脱掉沾上的衣服鞋袜，衣服兜住的地方伤得最重。第二步，用大量流动清水冲，皮肤和眼睛都至少 15 分钟，湖南省应急管理厅给到 20 到 30 分钟，按长的那个来。第三步，眼睛撑开眼皮冲，冲完直接去眼科。用常温水，不用热水。
- 收益：现场三步。第一步，立即脱去受污染的衣物鞋袜：毒物会继续经皮肤吸收，衣服兜着的部分伤得最重。第二步，用大量流动清水冲洗。中国疾控中心职业卫生与中毒控制所给的下限，是皮肤和眼睛各「至少 15 分钟」。湖南省应急管理厅给的口径是创面冲洗 20 至 30 分钟，「强烈的化学品要更长」。两个口径里取长的那个。第三步，眼睛要「撑开眼睑，确保水流充分接触眼球及眼睑内侧」，「切勿揉搓眼睛」，冲完立即去眼科。用常温或微温水，禁用热水。新鲜创面上不要涂油膏、红药水或者任何东西，也不要脏布包裹，涂了会影响医生判断深度。法律上，「化学性皮肤灼伤」和「化学性眼部灼伤」都在法定职业病目录里，工作中发生的按职业病和工伤走。发生急性职业病危害事故的，用人单位「应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担」（全国）
- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕强酸强碱清洁剂. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm；湖南省应急管理厅 (2015). 常见化学品中毒事故的应急处理与治疗. http://yjt.hunan.gov.cn/yjt/tszt/aqzs/201509/t20150919_3113778.html；国家卫生健康委等四部门 (2024). 职业病分类和目录（2025 年 8 月 1 日起实施）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992843.htm；全国人大常委会 (2018). 职业病防治法（第三十七条）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html（北京市人民政府转载）
- 备注：定 B 是因为冲多久这件事，两份官方材料一份写 15 分钟、一份写 20 到 30 分钟，没有统一的国家标准数字。去医院带上化学品的名字、包装，或者那张安全数据表（SDS），医生要靠它定方案。不要随手抓另一种酸或者碱去「中和」：两样兑到一起会放热，倒多少也没法控制。湖南那份

材料里说的「中和液」，指的是单位事先备好的专用冲洗液，不是现场拿东西对冲。石灰粉、水泥粉这类干粉先刷掉再冲水（有的地方应急页面据此说浓硫酸也要先擦干，这一点各处口径不一，本书不写）。家里的清洁剂和误服见第 20 条。上岗前的防护和体检见第 19 节第 9、10 条（上岗前看危害告知、防护用品单位必须给）。

22. 高温下头晕、恶心、不出汗或意识不清，立刻挪到阴凉处脱衣泼水降温，意识不清的不喂水、打 120

- 成本：不花钱。
- 说人话：皮肤烫红、说话含糊、意识混乱是热射病。从头晕到昏迷可以只有几十分钟，病死率极高。立刻挪到阴凉通风处、脱掉衣服、用凉水和湿毛巾降温，同时打 120。意识不清的一口水都不要喂，会呛。
- 收益：美国国家气象局：热射病是「严重的医疗急症」。它的表现是体温高于 103°F (39.4°C)、意识混乱、说话含糊、皮肤发烫发红。处理是立刻叫急救、移到凉处、用凉水和湿布降温、「不要给液体」。热衰竭的表现是大汗、乏力、皮肤湿冷、脉快而弱，处理是移到凉处、松开衣服、小口喝水；呕吐、恶化或者超过 1 小时不缓解就就医。云南省疾控局提示：立即转移到阴凉通风处，用冷湿毛巾降温，意识清醒的补含盐饮料，症状严重的立即拨打急救电话；重症热射病「病死率极高」。中国疾控中心提示：先降温，后转运，在病人失去意识后的「黄金半小时」内降温。有条件的，无基础疾病的青壮年可以用冷水浸泡快速降温，老人和有基础病的往皮肤上喷水、靠蒸发降温。荒野医学会 2024 年更新的热病指南说，冷水浸泡是治重症中暑最重要的办法，降温最快。没有冰水就用手边最凉的水，泡不了就喷水加扇风，速度大约是浸泡的一半
- 证据等级：B
- 来源：US National Weather Service. Heat Related Illnesses. <https://www.weather.gov/safety/heat-illness> ; 云南省疾控局 (2026). 出现这些症状，你可能是中暑了. https://ynsjkj.yn.gov.cn/html/2026/jikongkepu_0719/2606.html ; 中国疾病预防控制中心. 高温天气，中国疾控中心提醒您谨防中暑：「如有条件可用冷水浸泡的方法对无基础疾病的青壮年快速降温。老人和有基础疾病的患者可向皮肤喷水通过蒸发降温。降温应遵循“先降温，后转运”的原则」. https://www.chinacdc.cn/jkqp/ggws/hjyssj/202409/t20240906_296985.html ; 国家卫生健康委 (2010). 高温中暑预防知识要点. <https://www.nhc.gov.cn/wjw/jbyfykz/201007/1edb19b7dd4e4bdf8da5ea45f4a64e23.shtml> ; Eifling KP 等 (2024). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2024 Update. Wilderness & Environmental Medicine 35(1_suppl):112S-127S. <https://doi.org/10.1177/10806032241227924> (正文站点拒绝自动抓取，具体推荐按荒野医学会官网的更新摘要核对：「cold water immersion ... is the most important method of treating severe heat illness」「If CWI is unavailable, evaporative cooling is the recommended second-line treatment. ... generally half as fast as CWI」 <https://wms.org/magazine/magazine/1540/Heat-Illness-CPG/default.aspx>); Lipman GS 等 (2019). 同指南 2019 版. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2018.10.004>
- 备注：不要等「缓一缓」，热射病从头晕到昏迷可以只有几十分钟。不要给意识不清的人灌水，会呛。冰袋放哪里，两边说法不同。中国疾控说敷在脖子、腋窝和大腿根，荒野医学会说研究看不出敷这几处有降温效果。它的建议是，只有冰袋可用时就把全身盖满，冰袋不够再放脸颊、手心和脚底。两边都说有条件就用冷水浸泡。

23. 中暑的人只要清醒，就少量多次喝凉的淡盐水或运动饮料，别猛灌、别喝酒和高糖饮料

- 成本：不花钱。一瓶运动饮料几元。
- 说人话：只有清醒的人才喝。凉的淡盐水或运动饮料少量多次喝，一小时 500 到 1000 毫升。别猛灌，吐出来呛进气管更要命。不喝酒和高糖饮料，它们会让人丢更多水。先用凉水擦身、冰袋敷脖子腋下大腿根降温，再补水。意识不清、说话含糊的，一口都不喂。
- 收益：中国疾控中心发布过《公众高温中暑预防与紧急处理指南（2014 版）》。里面写着「至少每小时喝 2~4 杯凉水（500~1000ml），水温不宜过高，饮水应少量多次」。还写着「不要饮用含酒精或大

量糖分的饮料。这些饮料会导致失去更多的体液。同时，还应避免饮用过凉的冰冻饮料」。对热射病则明确写「不要给病人喝水」。美国 NIOSH：热衰竭要「鼓励小口频繁地喝凉水」；热痉挛每 15 到 20 分钟补一次含糖和电解质的运动饮料，「不要用盐片」

- 证据等级：B
- 来源：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 (2014). 公众高温中暑预防与紧急处理指南 (2014 版) . https://niohp.chinacdc.cn/sndt/201405/t20140530_97623.htm ; US CDC/NIOSH. Heat-Related Illnesses. <https://www.cdc.gov/niosh/heat-stress/about/illnesses.html>
- 备注：出大汗后只灌白开水，会把血里的盐冲淡（血钠低），所以水里要含一点盐。一次猛灌容易吐，吐的东西呛进气管比中暑本身更要命。「别喝冰镇的」是中国疾控 2014 年那版指南里的建议，理由是怕胃痉挛，没有量化证据。别把它误读成「不能用冷的」。第 22 条（高温下头晕恶心时脱衣泼水降温）里讲了几样降温法。分别是凉水擦洗、冷水浸泡、冰袋敷脖子、腋下、大腿根（腹股沟）。这几样正是官方推荐的头一档降温法，是往身上用的，不往嘴里灌。降温永远排在补水前面。意识不清、说话含糊的，一口都不要喂

24. 火灾时贴地爬、摸门再开门、门烫就别开，走楼梯不坐电梯，出去了别回头

- 成本：家里装 1 到 2 个独立烟感，几十元。提前看一眼楼道的两条出口。
- 说人话：趴到地上，从烟底下爬向出口。开门前先摸门把和门板，烫、或者门缝在冒烟，就别开这扇门，换第二条路。开门要慢，一冒浓烟立刻关上。走楼梯不坐电梯，一断电就困在里面。出去了不为拿东西回头。衣服着火就停下、倒地、打滚，用手护住脸。
- 收益：美国 FEMA 逃生原文：「趴到地上，从烟下面爬向出口」。开门前先摸门把和门板，「如果是热的，或者门缝有烟，别开这扇门，用第二条路」。开门要慢，一有浓烟立刻关上。衣服着火就「停下、倒地、打滚」，用手护脸。出不去就关门，用布或者胶带堵住门缝和通风口，打电话报位置。应急管理部的火灾自救提示和这一致：逃生不要坐电梯，火不大时尽量往楼下跑，用湿毛巾或口罩蒙住口鼻，趴着或弯腰撤离
- 证据等级：B
- 来源：US FEMA Ready.gov. Home Fires. <https://www.ready.gov/home-fires>；应急管理部 (2019). 公共场所火灾自救方法：「逃生时不要乘坐电梯，当火势不大时，要尽量往楼层下面跑」「可用湿毛巾或口罩蒙鼻，匍匐或弯腰撤离」. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/201904/t20190401_366015.shtml；贵州省消防救援总队 (2020). 消防常识 | 逃生三要点：「湿毛巾对折 3 次（叠成 8 层），除烟率比较高，但烟和毒气浓度过高时，过滤效果就无法保证了。另外，毛巾过湿会导致呼吸困难」. https://gz.119.gov.cn/xfkp/xfcs/202010/t20201026_71437855.html
- 备注：不要坐电梯，断电就困在里面。不要为拿财物回头。不要往上跑，除非确认楼顶门开着。不要跳楼。湿毛巾要对折 3 次叠成 8 层，水别太多，太湿反而喘不上气。烟和毒气太浓的时候，毛巾也挡不住。

25. 看到有人溺水，先叫人和打 110/120，伸竿、抛漂浮物，自己不下水

- 成本：不花钱。难的是忍住往下跳的冲动。
- 说人话：溺水的人会本能地把施救者往水下按，下水的人自己也可能淹死。顺序是：大喊叫人 → 打 110/120 → 递长杆、绳子 → 抛救生圈、空桶、矿泉水瓶 → 人上岸没呼吸就立刻按压。不结手拉手的链子下水。全球每年约 30 万人溺亡，这是 1 到 4 岁孩子的第四位死因。
- 收益：WHO：全球每年约 30 万人溺亡，92% 在中低收入国家。溺水是 1 到 4 岁儿童的第四位死因，5 到 14 岁的第三位死因。WHO 推荐的干预是「安全救援和复苏培训」，比如先学会不下水的救法。顺序是：大喊叫人 → 打电话 → 递长杆、绳子，抛救生圈、空桶、矿泉水瓶 → 人上岸后无呼吸立刻按压
- 证据等级：C
- 来源：WHO. 溺水 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/drowning>

- 备注：C 级原因是「不下水」这条规则没有找到官方原文，只有 WHO 的死亡数字和「安全救援」的方向。不要手拉手结成链子下水。没受过训练就不要去拖人，溺水者会把施救者往下按。「不下水」同样是自利规则：下水的人自己淹死，水里那个是谁都一样。真要救的多半是自家孩子，怎么防在第 1 节第 12 条（儿童近水不离视线）。有人掉进冰窟窿，同样不跑上冰面去拉，冰面怎么防见第 1 节第 41 条（野外冰面先量厚度）。

26. 有人噎住说不出话，站到背后做 5 次拍背加 5 次腹部冲击，倒下就做心肺复苏

- 成本：不花钱。看一遍动作：一手握拳顶在肚脐上方，另一手包住，向内向上快速冲击。
- 说人话：先问「你噎住了吗，能说话吗」。还能用力咳、能出声的不要动手，让他咳。说不出话就站到背后，5 次拍背接 5 次腹部冲击，反复做到东西出来或者人倒下。倒下就做心肺复苏，同时叫人打急救电话。孕妇和很胖的人改冲胸口。别伸手去嘴里掏看不见的东西。
- 收益：美国国立医学图书馆原文：先问「你噎住了吗，能说话吗」。「能用力咳嗽、能说话的不要动手」，咳嗽本身多能把异物咳出。说不出话就「反复做 5 次拍背接 5 次腹部冲击，直到异物出来或人失去意识」。「失去意识就开始心肺复苏」，同时叫人打急救电话。孕妇、肥胖者改做胸部冲击
- 证据等级：B
- 来源：US National Library of Medicine, MedlinePlus. Choking – adult or child over 1 year. <https://medlineplus.gov/ency/article/000047.htm>；福州市卫生健康委员会 (2026). 海姆立克急救法更新了：「1 岁以上幼儿、儿童及成人：从旧版单一腹部冲击改为“5 次背部拍击+5 次腹部冲击”的循环」「中国红十字系统急救培训一直都是按“5 次背部拍击+5 次腹部冲击”循环进行的方式进行教学」。 https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzst/swjw/fzwj/jkjp/202601/t20260108_5268351.htm
- 备注：不要往嘴里伸手掏看不见的东西，会推得更深。不要拍还能咳嗽的人。噎住最常发生在自家饭桌上，受益的主要是家里人。国内的教法也是这一套：福建省红十字应急救援培训中心说，1 岁以上的孩子和成人，中国红十字系统一直按 5 次拍背加 5 次腹部冲击循环来教。网上不少老教程只教腹部冲击，那是旧版。不满 1 岁的孩子不按肚子，改按胸口，见本节第 43 条（婴儿噎住）。

27. 在戈壁、沙漠、无人区迷路或车坏了，留在原地或车旁，先报位置，再遮阳保温，省水，不乱走

- 成本：进无人区前告诉别人路线、目的地、返回日期、车型车牌。每人每天 4 升水起。卫星通讯器或者北斗短报文设备上千元，租一次几百元。难的是守住「留在原地不乱走」。
- 说人话：留在原地或者车旁，车是最大的遮阳物。顺序是：有信号先发位置再打电话 → 遮阳保暖 → 省水，白天不动、夜里凉了再动 → 不乱走 → 用反光镜、烟、三堆火发信号。进去之前把路线、目的地、返回日期和车型车牌告诉别人。
- 收益：美国国家公园管理局的莫哈韦沙漠页面有三句原文。一句是「每人每天至少 1 加仑（约 3.8 升）水，徒步和骑行者每人每天 2 加仑」。一句是「告诉别人你的路线、目的地、返回日期、车型和车牌」。还有一句是「手机信号时有时无」。死亡谷原文：「热的时候不要在谷底和低海拔徒步」，荒野区域「几乎没有手机信号」，推荐带卫星电话。莫哈韦的沙漠驾驶页面原文：「出了紧急情况，待在车旁是你能做的最重要的事」。页面还说，这种事不常见，但确实有人在走向公路的路上，死于暴露在酷热或寒冷里。优先级分五步。第一步是报平安和坐标，有信号时先发位置再打电话。第二步是遮阳保暖，车是最大的遮蔽物。第三步是水，白天不动、夜里凉了再动。第四步是不乱走。第五步是信号。重庆市应急管理局的提示是：摆成三角形的三堆火是国际通行的求救信号。离得近就喊「三声短、三声长、再三声短」，隔 1 分钟重复。有太阳时用镜子、罐头盖这类亮东西反光。文化和旅游部提醒自驾游游客谨慎前往无人区，尽量多车同行，必要时租卫星电话
- 证据等级：C
- 来源：US National Park Service. Mojave National Preserve Safety. <https://www.nps.gov/moja/planyourvisit/safety.htm>；US National Park Service. Death Valley Safety. <https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/safety.htm>；US National Park Service. Desert Driving Safety. <https://www.nps.gov/articles/000/desertdrivingsafety.htm>；重庆市应急管理局 (2024). 应急科普>>在野外你需要了解的求救信号

(长图)：「燃放三堆火焰是国际通行的求救信号，将火堆摆成三角形」「三声短三声长，再三声短；间隔 1 分钟之后再重复」. https://yj.jq.gov.cn/yjqp/scshaq/202409/t20240918_13639172.html；文化和旅游部 (2018). 文化和旅游部提醒游客谨慎选择户外探险旅游：「谨慎前往无人区和人烟稀少区」「尽量多车同行，提前准备对讲机，必要时租用卫星电话」. https://www.mct.gov.cn/zxbs/cxts/201811/t20181127_836244.htm

- 备注：C 级原因是这些都是官方提示，不是研究数据。饮水量、报备、信号覆盖、待在车旁、求救信号都是官方原话。流传的「三声一组」没有找到官方原文，所以改写成官方的三堆火和三短三长三短。不要在正午徒步找路。不要喝尿。不要为了省水而不喝。

28. 发抖、说话含糊、走路打晃是失温，换掉湿衣、包起来，先暖躯干，喝热甜饮不喝酒

- 成本：一张铝箔保温毯几元，再加一件备用干衣。学会看信号不花钱。
- 说人话：体温降到 35°C 以下就是失温，人会发抖、说话含糊、走路打晃、想不清楚事。换掉湿衣服，用保温毯或者干衣裹起来，先暖躯干、不先暖手脚。给热的甜饮料，不给酒，酒会压住寒战。不抖了不是好转，是加重。没有意识就做心肺复苏。
- 收益：美国国家气象局原文：体温 95°F (35°C) 以下就是失温，「觉得冷、迟钝、想不清楚，立刻看医生」。处理是「立即就医，把人移到有暖气的室内，先从身体中心开始复温」，给热饮。「酒精会减少寒战」，所以不喝。「失去意识做心肺复苏」。冻伤用温水或者体温回暖，「不要用热水或壁炉一类辐射热」。荒野医学会 2019 年失温指南是这个领域的执业指南
- 证据等级：B
- 来源：US National Weather Service. During Extreme Cold. <https://www.weather.gov/safety/cold-during>；Dow J 等 (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update. Wilderness & Environmental Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2019.10.002>
- 备注：不要搓手脚。不要泡热水澡。不要硬拖硬拽地搬，失温重的人心脏容易骤停。不要因为「不抖了」就以为好转，不打哆嗦（寒战停止）是加重。荒野医学会指南全文需订阅，本次只核对了摘要。

29. 被蛇咬，坐下别动、摘掉戒指手表、尽快送医院打抗蛇毒血清，不切、不吸、不绑死

- 成本：不花钱。提前知道附近哪家医院有抗蛇毒血清。难的是忍住自己动手处理伤口。
- 说人话：坐下别动，把被咬的肢体固定住。先摘掉戒指手表，接下来会肿。尽快送到有抗蛇毒血清的医院，血清是唯一能逆转大部分毒性作用的东西。不切开，不用嘴吸，不冰敷，不用绳子勒到发紫。别喝酒，别跑动。能远远拍张蛇的照片就拍，别去抓。
- 收益：WHO 原文有三句。一句是「立即完全固定被咬的身体部位，并迅速送到最近的医疗机构就医」。一句是「避免使用止血带，并避免切割伤口」。还有一句是「用针对当地蛇种的适当抗蛇毒血清进行治疗」。「高质量抗蛇毒血清是防止或逆转蛇咬伤的大部分毒性作用的最有效治疗方法」。全球每年约 8.1 万到 13.8 万人死于蛇咬伤，截肢和永久残疾的人数约为死亡数的 3 倍。中国 2024 年的蛇伤救治指南估计，国内每年有 25 万到 28 万例毒蛇咬伤，被咬的多是 50 岁以上的人。长江流域和南方 11 个省的医院 2017 到 2021 年收治了 40817 名蛇伤病人，住院期间死亡 23 人 (0.06%)
- 证据等级：B
- 来源：WHO. 动物咬伤 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites>；WHO (2023). 蛇咬伤中毒 实况报道. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/snakebite-envenoming>；Lai R 等 (2024). The Chinese guideline for management of snakebites. World Journal of Emergency Medicine 15(5):333-355：「An estimated 250,000–280,000 cases of venomous snakebites occur in China each year, affecting mainly patients aged ≥50 years」. <https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2024.076>；Yan S 等 (2026). Clinical epidemiology of snakebite envenoming in hospitals 11 provinces of Yangtze River Basin and southern regions of China. PLoS Neglected Tropical Diseases：「withdrawal (4346, 10.65%), and death (23, 0.06%)」. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013247>

- 备注：能拍到蛇的照片就拍，别去抓。不要喝酒，不要跑动，不要用嘴吸，不要冰敷，不要用绳子勒到发紫。中国的全国蛇伤死亡数没有官方统计。那 11 个省的住院死亡率看着低，但有一成多病人没治完就自己出院了，他们后来怎样不在统计里。

30. 地震时先看自己在什么房子里：符合抗震设防的楼里就地躲，会垮的老房子门在几步外就出去

- 成本：不花钱。提前看一眼自己家出门要几步、走哪条路、哪张桌子结实。
- 说人话：先看自己在什么房子里。2001 年以后按规范建的楼，要下楼梯、穿门厅才能出去的，就地躲：护住头颈钻到结实桌子下面，抓牢桌腿。平房、老砖房、没抗震设防的自建房，门就在几步外，出去。任何情况都不跳楼、不坐电梯、不在摇晃中下楼梯。
- 收益：中国地震局科普片《地震来了，是躲还是跑？》的口诀是「震时就近躲避，震后迅速撤离」，并明确限定「这里指的是在符合抗震设防要求的建筑内」。理由是这类建筑「整体垮塌的可能性较小」。原文说「坠落的建筑构件及装饰物品」才是对生命安全最大的威胁」。而「震时无保护措施的盲目乱跑」「反而容易被坠落的天花板、吊灯（扇）等物品砸伤」。躲的做法是「用手或者其他软物保护好头颈部」「并牢牢地抓住桌腿」；没有桌子就「迅速贴紧承重墙蹲伏」「避开外墙、窗户、阳台」。「如果在户外」则「应该第一时间疏散到空旷的地方避震」。反过来看，1988 年亚美尼亚地震是苏联式预制板楼成片垮塌。那次的病例对照研究写着，「第一下震动之后离开建筑是保护性行为」。待在室内的人受伤的可能性，是跑出去的 4.40 倍（比值比 4.40），95% CI 2.24–8.71（可信范围）。在建筑里受伤的可能性，是在室外的 12.20 倍（3.62–63.79）。在 5 层以上的楼里，是在更矮的楼里的 3.65 倍（2.12–6.33）
- 证据等级：B
- 来源：中国地震局（安徽省地震局制作）。地震来了，是躲还是跑？（科普视频，字幕转录）。
<https://www.cea.gov.cn/cea/dzpd/dzcs/5537260/index.html>；Armenian HK, Noji EK, Oganessian AP (1992). A case-control study of injuries arising from the earthquake in Armenia, 1988. Bulletin of the World Health Organization, 70(2), 251-257. <https://europepmc.org/article/MED/1600585>；US FEMA Ready.gov. Earthquakes. <https://www.ready.gov/earthquakes>；Mahue-Giangreco M, Mack W, Seligson H, Bourque LB (2001). Risk factors associated with moderate and serious injuries attributable to the 1994 Northridge Earthquake. Annals of Epidemiology, 11(5), 347-357. [https://doi.org/10.1016/s1047-2797\(01\)00220-4](https://doi.org/10.1016/s1047-2797(01)00220-4)
- 备注：争议，两种结论针对的是两种房子。中国地震局自己也把「躲」的前提写成了「符合抗震设防要求的建筑内」。它还要求「因地制宜」「因人而异」，一起看楼抗不抗震、你人在哪个位置、自己跑不跑得动。亚美尼亚那批楼整栋垮塌，躲无处可躲，出去才占优。美国 FEMA 对本国住宅给的是「就地趴下、护住头颈、抓牢，不要往外跑」，那里的伤主要来自坠物和摇晃中移动摔倒。Northridge 的研究还提示，伸手去接东西、扶住「看起来稳」的东西会加重受伤。所以光问「跑不跑」没用，要判断「这栋楼会不会垮、你几秒内能不能到空地」。2001 年以后按规范建的楼房，需要下楼梯或者穿门厅的，就地躲。平房、老旧砖房、无抗震设防的自建房，门就在几步外，出去。亚美尼亚这项研究只比了幸存者中受伤与未受伤的，没把遇难者算进去，也没说明有没有把楼层高低的影响扣掉。能跑出去的人本来就可能住在低层，数字要打折看。任何情况下都不跳楼、不坐电梯、不在摇晃中下楼梯。到室外要远离高大建筑、高架桥、电线杆、玻璃幕墙和广告牌。

31. 遇到熊、野猪、成群野狗，别跑、别尖叫、别对视，侧身慢慢退开

- 成本：不花钱。进山带根登山杖，结伴走、出声走，让动物先知道你来了。难的是站住不跑。
- 说人话：别跑，熊上下坡都跑得像赛马。也别爬树，黑熊棕熊都会爬。站住，低声一直跟它说话，等它不动了再侧身慢慢退开。棕熊扑上来就趴下装死，双手扣在颈后、两腿分开。黑熊扑上来不装死，往车里或屋里跑，跑不掉就拿手边东西反击。被狗抓咬按第 13 条冲洗打针。
- 收益：美国国家公园管理局关于熊的原文有六句。一句是「不要跑，熊上下坡都能跑得像赛马一样快」。一句是「保持冷静，大多数熊不想攻击你，只想被放着不管」。一句是「用低沉的声音持续跟

熊说话」。一句是「熊不动时，侧着身慢慢退开，这样既能盯着熊又不会绊倒」。一句是「让自己显得尽量大」。还有一句是「不要爬树，灰熊和黑熊都会爬树」。被棕熊攻击时「装死，趴着双手扣在颈后、双腿分开」。被黑熊攻击时「不要装死，逃向车或房子，逃不了就用手边任何东西反击」。被狗咬伤按第 13 条处理

- 证据等级：B
- 来源：US National Park Service. Staying Safe Around Bears. <https://www.nps.gov/subjects/bears/safety.htm>；国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅 (2023). 狂犬病暴露预防处置工作规范（2023 年版）. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1706569159854649344.html
- 备注：B 级只对应熊。野猪和野狗的「不跑、慢退、找高处或者障碍物挡」是经验，算 C 级，国家林草局和地方林草的官方提示本次未找到。不要拿食物引，不要凑近拍照，不要带狗进有野猪的山。中国的熊多是黑熊和棕熊，装死还是不装死，按这两种分开看。

32. 野外遇上雷雨，钻进有硬顶的车或建筑，避开山脊、孤树、水面和金属

- 成本：不花钱。代价是行程被打断半小时以上。难的是雷声还远的时候就肯往回走。
- 说人话：雷暴范围内的户外没有安全的地方。钻进硬顶的车或者建筑，敞篷车、摩托、帐篷、凉亭、树下、突出的岩石下面都不算。避开开阔地、山脊山顶、孤立的大树、水面和铁栏杆。一群人走不了就散开站。听见雷就撤，最后一声雷过去 30 分钟才算安全。
- 收益：雷暴范围内的户外没有安全的地方。最后一声雷响过 30 分钟，才算安全
- 证据等级：B
- 来源：美国国家气象局. 户外雷电安全：「There is no safe place outside when thunderstorms are in the area」「Avoid open fields, the top of a hill or a ridge top. Stay away from tall, isolated trees or other tall objects」「Stay away from water, wet items, such as ropes, and metal objects, such as fences and poles」；实在走不了时「If you are in a group, spread out to avoid the current traveling between group members」；恢复活动「Wait 30 minutes until after the last rumble of thunder」. <https://www.weather.gov/safety/lightning-outdoors>
- 备注：帐篷、凉亭、树下、岩石突出部都不算掩体。硬顶汽车算，敞篷车和摩托不算。听见雷就开始撤，不要等雨下下来。

33. 上高原按睡眠海拔（当晚睡在多高）慢慢升，症状加重就下撤，不要硬扛

- 成本：多花一到两天做适应。预防药是处方药，要在出发前问医生。难的是行程排得紧时还肯留出这几天。
- 说人话：算的是睡在多高，不是白天到过多高。睡在 2450 米以上就有高原病风险。过了 3000 米之后，每晚睡觉的高度只往上加 500 米，每升 1000 米多留一天适应。头痛加恶心、走路打晃、意识变化，或者不动也喘不上气，就往下走。下撤排在吸氧和吃药前面。
- 收益：睡在 2450 米以上就有高原病风险。高原脑水肿和肺水肿（脑子和肺里积水），不及时往低处撤会死
- 证据等级：A
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 黄皮书·高海拔旅行与高原病：「Any unacclimatized traveler proceeding to a sleeping altitude of $\geq 2,450$ m ($\geq 8,000$ ft)—and sometimes lower—is at risk for altitude illness」；上升速度「500 m (1,650 ft) per night in sleeping altitude once above 3,000 m (9,800 ft)」，每上升 1000 米加一天适应日；乙酰唑胺预防「125 mg twice a day; 250 mg twice a day if >100 kg body weight」；「If symptoms become worse despite rest or treatment at the same elevation」必须下撤. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/environmental-hazards-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness.html>；荒野医学会 (2024). 急性高原病预防、诊断与治疗临床实践指南（2024 更新）. Wilderness & Environmental Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2023.05.013>
- 备注：算的是「睡在多高」，不是白天到过多高。头痛加恶心、走路打晃、意识变化，或者不动也喘不上气，都是往下走的信号。下撤优先于吸氧和吃药，吸着氧继续往上是错的。

34. 被蜱虫叮住，用尖头镊子贴着皮肤稳稳拉出来，别涂油别用火烧

- 成本：一把尖头镊子。
- 说人话：用尖头镊子贴着皮肤夹住蜱的头部，稳稳地朝外拉出来。别涂油，别用火烧，别扭着拽，那会刺激它把带病原体的体液挤进皮肤，还容易把口器留在肉里。拔完记下日期。之后几周里发烧、起疹、乏力，看病时主动说被蜱咬过。
- 收益：涂油、用火烧、扭着拽，会刺激蜱虫，把带病原体的体液挤进皮肤。这么做也容易把它扎在肉里的那部分嘴（口器）留在里面。蜱虫在中国传的发热伴血小板减少综合征，2024 年全国报告 6602 例、死亡 306 例，都是发现这种病以来最多的一年。2010 到 2024 年平均病死率 4.79%，年纪越大越高，85 岁以上是 9.15%
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 被蜱叮咬之后：「Grasp the tick as close to the skin's surface as possible using clean fine-tipped tweezers」「Pull tick away from the skin with steady, even pressure」「Do not use petroleum jelly, heat, nail polish, or other substances to try and make the tick detach from the skin. This may agitate the tick and force infected fluid from the tick into the skin」. <https://www.cdc.gov/ticks/after-a-tick-bite/index.html>；Ren Q 等 (2026). Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in China, 2010–2024: a fifteen-year national surveillance analysis. BMC Infectious Diseases 26:1497：「The number of reported cases (6,602 cases) and deaths (306 cases) in 2024 were both the highest levels since the discovery of this disease」「The average CFR was 4.79%, and the CFR increased with age, reaching 9.15% among those aged 85 years and above」. <https://doi.org/10.1186/s12879-026-14066-z>
- 备注：拔完把日期记下来。之后几周里发烧、起皮疹、乏力，看病时主动说被蜱咬过。医生不问、你不说，很容易被按感冒处理。

35. 野外的水一律烧开再喝，滚开一分钟就够，不用因为海拔高多煮

- 成本：多背一套炉具和燃料的重量。
- 说人话：所有能靠喝水致病的微生物，在沸点温度下几秒就死了。再滚一分钟，只是给「看走眼」留的余量，不用因为海拔高就多煮。烧不了就用过滤器或者消毒片，这两样各有覆盖不到的病原体，能烧还是烧。看着清澈的溪水、雪水一样可能有寄生虫。
- 收益：所有能靠喝水致病的微生物，在水烧开的温度下几秒就被杀死（灭活）。「高海拔水烧不到位」是常见误解
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 黄皮书·旅行者的水消毒：「All organisms that may cause illness from drinking water are killed within seconds at boiling temperature」「CDC recommends that travelers boil water for a full minute to account for user variability in identifying boiling points and to add a margin of safety」「Although the boiling point for water decreases with increasing elevation, at common travel elevations the temperature needed to achieve boiling is still well above the temperature required to inactivate enteric pathogens」. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/preparing-international-travelers/water-disinfection-for-travelers.html>
- 备注：同一页也写了不必真的烧开：60℃ 保持 30 分钟同样有效，烧开只是不用温度计就能看见的终点。烧不了就用过滤器或者化学消毒片，两者各有覆盖不到的病原体，能烧就烧。看起来清澈的溪水、雪水一样可能有寄生虫，别凭外观判断。

36. 荒郊野外被陌生人索财，钱给他，不动手，记特征，脱身后报警

- 成本：身上的现金。难的是压住火气。
- 说人话：钱给他，不动手，不还嘴。对方为几百块冒的是抢劫罪：三年以上十年以下起步，入户、持枪、致人重伤死亡的十年以上，直到死刑。他拿了钱转身走，你追上去打就不再算正当防卫。脱身后立刻记下体貌、口音、车牌和逃跑方向，打 110。

- 收益：命比钱贵，对方为几百元冒的是重罪。刑法第二百六十三条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。持枪、入户、致人重伤死亡等情形，判十年以上直至死刑。刑法第二十条的正当防卫只保护「制止正在进行的不法侵害」。对方拿了钱转身走，你追上去打就不再是防卫。脱身后立刻记下体貌、口音、车牌、逃跑方向，打 110
- 证据等级：C
- 来源：全国人大 (2020 年修正). 刑法（第二十条、第二百六十三条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安交管局转载整合文本）
- 备注：C 级原因是「给钱不对抗更安全」没有直接文献，法条只说明对方的风险和你的边界。不要跟去偏僻处「取钱」。不要交手机密码。不要上对方的车。先给钱只限当面被堵住、人身安全受威胁的场合，脱身后照样报警。网上被人拿隐私照片、裸聊录像来要钱是反过来的，一分钱都不能给，见第 8 节第 32 条（对方拿把柄来要钱）。别指望随身带的甩棍、电击器、匕首，带着出门本身就会被罚，见第 9 节第 26 条（别为了防身买甩棍、电击器）。

37. 撞见一群人打架，退开走人，别上去拉架、别围观、别捡地上的家伙；要报警就退到安全距离打 110

- 成本：不花钱。难的是忍住上前拉一把、以及站着看热闹这两种冲动。报警之后可能被回访做一次笔录，最多搭进半天。
- 说人话：你一动手，劝架就成了参加打架。参加聚众斗殴判 3 年以下，人多、在马路、拿了家伙的判 3 到 10 年。围观也容易被误伤。该做的是退开走人。愿意报警就退到安全距离打 110，说清地点、几个人、有没有拿刀棍、有没有人躺下不动。
- 收益：刑法第二百九十二条：「聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制」。多次聚众斗殴的，人数多规模大社会影响恶劣的，在公共场所或者交通要道造成社会秩序严重混乱的，持械的，「处三年以上十年以下有期徒刑」。「聚众斗殴，致人重伤、死亡的」，按故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。治安管理处罚法也有罚则。殴打他人，拘留 5 到 10 日并罚 500 到 1000 元。结伙斗殴按寻衅滋事处理，最高拘留 15 日并罚 2000 元。《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第 5 条：不法侵害「既包括针对本人的不法侵害，也包括危害国家、公共利益或者针对他人的不法侵害」。该意见第 9 条：一方先动手且手段明显过激，或者一方先动手、在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害的，还击一方一般应当认定为防卫行为
- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第二百三十二、二百三十四、二百九十二、三百零五、三百一十）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第三十、五十一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2020). 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31 号，第 5、9 条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>；全国人大 (2018). 刑事诉讼法（2018 年修订，第六十二、一百一十、一百一十一、一百九十三）. 宁夏回族自治区人民检察院转载全文 https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 备注：定 B 是因为后果那一半有硬条文，但「退开报警、不上手拉架」这一步没有官方原文，是从条文和「互殴怎么认定」推出来的。「我是来劝架的」不是护身符，认定看的是你动没动手、打了谁。对方已经倒地或者跑了，你还追上去打，就不再算防卫。看到有人被围着单方面挨打，法律上你确实可以制止。正当防卫保护的不仅是自己，也包括别人。但徒手上去多半只是再添一个伤员。喊人、远远录像、报警更管用。「不上手、不围观」对你只有好处。打 110 的好处主要落在地上那个人身上，属于本书受益人里最低的那一档，愿不愿意花这个时间你自己权衡。权衡之前要知道几件事。作证义务本来就有：刑法第六十二条写明，凡是知道案件情况的人都有作证的义务，不打这个电话它也不会消失。出了重伤或者人命，警方调监控照样找到在场的人，站着围观反而最容易被登记。报案人不愿公开姓名的，办案机关「应当为他保守秘密」（第一百一十一条）。说清地点、人数、有没有拿家伙就可以挂，不必留在原地。会走到训诫或者十日以下拘留的，是法院通知你出

庭、你又拿不出正当理由还不肯作证（第一百九十三条），路人极少走到这一步。不报警本身不违法：刑法第一百一十条那句「有权利也有义务」没有罚则，刑法里也没有处罚普通人知情不报的罪名，走开是合法选项。走开之后的红线只有两条。一是事后帮着藏人或者作假证明包庇（刑法第三百一十条，3 年以下，情节严重 3 到 10 年）。二是被找去做证时故意作假证（第三百零五条，3 年以下，情节严重 3 到 7 年）。沉默和如实说都没事，编话才有事。自己被卷进冲突见第 8 节第 10 条，被陌生人索财见本节第 36 条，救人受伤之后的钱见本节第 39 条。

38. 可能被 HIV 暴露了，72 小时内去拿阻断药，越早越好

- 成本：一个 28 天疗程的药费上千元，多数地区自费。当晚就得跑一趟医院。难的是当场承认自己可能被传染，立刻出门。
- 说人话：怀疑自己被传染上艾滋病，72 小时是硬线，最好 2 小时内就吃上药。药要连吃 28 天。超过 72 小时这条路就没了，所以别等到第二天再决定。
- 收益：北京市人民政府防艾科普栏目的口径是：接触之后的预防用药叫暴露后预防（英文缩写 PEP），应「尽可能在 2 小时内进行预防性用药，最好在 24 小时内、不超过 72 小时」。还要「连续服用 28 天」。超过 72 小时就不再建议启动，这是一条硬时限
- 证据等级：B
- 来源：北京市人民政府. 事前、事后分不清？六问六答全面了解艾滋病病毒暴露前/暴露后预防。https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/jhsyfwzdzx/sjazbr/fakp/202311/t20231110_3299397.html；中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 (2020). 艾滋病病毒暴露后预防技术指南（试用）. https://www.chinacdc.cn/jkyj/crb2/yl/azb/jswj_azb/202410/t20241027_302131.html
- 备注：去哪里拿：当地疾控中心指定的艾滋病定点医疗机构，通常挂感染科（性病艾滋病门诊）。不少城市已经建了 24 小时门诊，重庆的公开数据是 26 个区县 29 家门诊，其中 14 家全天候。去之前打当地疾控电话问哪家有药，别在急诊科耗时间。算「暴露」的情况包括没做防护的性行为、安全套破了、被针头扎到、血沾到黏膜上，到底用不用药由医生判断。药必须吃满 28 天，漏几次会让效果明显变差。之后按医嘱在第 4 至 6 周、3 个月复查。阻断药只是补救，日常预防和检测见第 1 节第 30、31 条（全程用安全套、有过高危行为就去查）。

39. 救人受了伤、搭进了钱，先找加害人和医保，再去申报见义勇为确认

- 成本：不花钱。申报要交材料、等认定，跑几趟，几周几个月。
- 说人话：救人把自己搭进去，不用自认倒霉。见义勇为负伤的先救治、后收费。医疗费由加害人出，人跑了或者赔不起的走基本医保。没有加害人的，被你救下的人依法应当给适当补偿。同时去申报见义勇为确认，受了伤的按工伤保险待遇落实。
- 收益：民法典第一百八十三条：「因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿」。国办发〔2012〕39 号讲了见义勇为负伤人员怎么办。医疗机构要建立绿色通道，「坚持『先救治、后收费』的原则」。医疗费这一块儿的原文是「因紧急救治发生的医疗费用，有加害人或责任人的，由加害人或责任人承担；无加害人或责任人以及加害人或责任人逃逸或者无力承担的，按规定通过基本医疗保障制度解决」。死亡的，「符合烈士评定条件的，依法评定为烈士」；「属于视同工伤情形的，享受一次性工亡补助金以及相当于本人 40 个月工资的遗属特别补助金」。伤残的，「符合享受工伤保险待遇条件的，依据《工伤保险条例》落实相应待遇；不符合的，由民政部门评定伤残等级并落实相应待遇」。就业上「优先纳入就业援助，予以重点支持」，公益性岗位「优先安排符合条件的见义勇为人员」。住房上「优先纳入住房保障体系，优先配租、配售保障性住房或发放住房租赁补贴」
- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一百八十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；国务院办公厅转发民政部等部门 (2012). 关于加强见义勇为人员权益保护的意见（国办发〔2012〕39 号）. https://www.gov.cn/zwggk/2012-07/26/content_2191928.htm

- 备注：定 B 是因为能拿什么待遇由全国文件定死，但奖金给多少、怎么走认定，是各省自己的见义勇为条例说了算，数字各地不同，本轮未逐省核实。一般是向出事地方的公安机关或者见义勇为工作机构（基金会）申报。能不能认定靠证据：报警回执、现场监控、目击者的姓名和电话、医院病历，当场就留下来。要打官司，见义勇为的民事权益本来就在免费法律援助的范围内。一次性工亡补助金的全国标准和伤残等级怎么换算成钱，见第 19 节第 14、15 条。法律援助怎么申请见第 7 节第 3 条。

40. 刀、钢筋、玻璃扎进身体，压住异物周围止血，不要把它拔出来

- 成本：不花钱。难的是忍住「先拔出来」的本能，守着人等救护车。
- 说人话：拔出来可能造成大出血，也会让医生更难判断伤了多深。做法是：打 120，用手或者敷料压住异物周围止血，把异物垫稳别让它晃。肚子上的伤口有内脏露出来，不要往回塞，盖一块干净的湿敷料。胸口的伤口在冒泡的，别用塑料布封死，封死可能把肺压瘪。
- 收益：国际红十字与红新月会联合会 2025 年国际急救指南：「急救的人应当压住扎进身体的异物（比如刀）周围，把异物稳住，不要把它拔出来」。「不要从腹部或胸部的伤口里拔出任何扎入的异物，拔出来可能造成大出血，也会让医生更难判断伤得有多重」。「扎在身体里的异物应当稳住；异物随脉搏跳动的，就让它跳，松松地稳住即可」。「急救的人不应把露出来的内脏塞回体内」。没有往外涌血的开放性胸壁伤口「可以敞着、不加敷料，因为把伤口封死可能让空气积在胸腔里，使肺部分或完全塌陷（气胸）」。所有穿透性胸腹部伤口都应立即呼叫急救。
- 证据等级：B
- 来源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025, 第 256–257、267–268 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>
- 备注：定 B 是因为这是指南里的公认做法，没有随机试验，总不能把伤者分成「拔」和「不拔」两组来试。唯一的例外是异物堵住气道、人喘不上气。到了医院直接找急诊门口那张分轻重缓急的台子（预检分诊台），报「穿透伤」。这属于要立刻进抢救室的那一级，不要去挂号窗口排队（见第 24 节第 7 条）。真扎穿了就打 120，救护车会提前通知医院准备接诊。大出血怎么压、怎么上止血带见第 12 条。

41. 怀疑骨折就别再动那个部位，托着不动、冷敷 20 分钟以内，别自己掰正

- 成本：不花钱。找块硬板、卷起的杂志或者衣物当支撑。冷的东西隔层布敷。
- 说人话：手脚受了伤先当骨折处理，能站能动也排除不了。伤处保持不动，用手托住或用硬板在原位撑住，冷敷一次不超过 20 分钟。别自己掰正，骨头戳出皮肤的先止血，别按回去。X 光可能漏看骨折。片子正常但医生仍怀疑骨折或者韧带伤的，按医生说的复查或做核磁。
- 收益：国际红十字与红新月会联合会发布了 2025 年国际急救指南。里面写着「手脚上的任何一处伤，都应当先按可能的骨折来处理」。还写着「确诊骨折唯一准确的办法是拍 X 光。拿不准就当骨折办」。固定的目的是「尽量减少活动和疼痛」。冷敷「一次最多连续 20 分钟，这样可以减轻疼痛；冷得比这更久可能损伤皮肤」。「伤到股骨这类长骨时，光是骨头本身出的血就可能致命」。疼痛或者肿胀明显、有休克表现、股骨（大腿骨）骨折或者肢体位置明显不对时，应呼叫急救。折弯成角的骨折，要两个条件同时成立，才考虑在现场掰回原位（复位）。一是「地处偏远（或者条件有限），而且成角处下方的肢体发凉、发白，或者急救的人没法固定好以便搬动」。二是施救者受过训练。开放性骨折（断骨戳破皮肤）的优先事项是止血和防感染。但第一次 X 光没看出来，不等于没骨折。英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）的髌部骨折指南写：X 光正常但仍怀疑髌部骨折的，「做磁共振（核磁）」。24 小时内做不了，就考虑做 CT。它的骨折指南写：怀疑手腕舟骨骨折的，「经过仔细的体格检查后，考虑首先做磁共振」。舟骨是手腕里的一块小骨头。考克兰（Cochrane）的一篇文献汇总说：「最初的 X 光片不能排除骨折」。它收的研究里，X 光正常、医生仍怀疑舟骨骨折的人，真有骨折的比例中位数是 20%。美国放射学会有一份膝关节外伤的检查标准。

它写：X 光没看到骨折，但仍怀疑有隐藏骨折或关节内部损伤的，下一步「通常适合」做磁共振。它还写，磁共振查隐藏骨折、半月板和韧带损伤都很准

- 证据等级：B
- 来源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025, 第 301–302 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>; National Institute for Health and Care Excellence (2011). Hip fracture: management. NICE guideline CG124, 第 1.1.1 条. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg124/chapter/Recommendations>; National Institute for Health and Care Excellence (2016). Fractures (non-complex): assessment and management. NICE guideline NG38, 第 1.2.3 条. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng38/chapter/Recommendations>; Mallee WH 等 (2015). Computed tomography versus magnetic resonance imaging versus bone scintigraphy for clinically suspected scaphoid fractures in patients with negative plain radiographs. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010023.pub2>; Taljanovic MS 等, Expert Panel on Musculoskeletal Imaging (2019). ACR Appropriateness Criteria: Acute Trauma to the Knee, Variant 3. American College of Radiology. <https://acsearch.acr.org/docs/69419/Narrative/>
- 备注：定 B 是因为这些都是公认做法。送医院之前给股骨（大腿骨）骨折做牵引固定，只有一项翻旧病历的研究撑着，证据可信度很低。结果是 24 小时内输血量更少、住院更短，死亡和并发症的差别小到说不清。至于先复位（把骨头对回原位）还是原样固定，根本没找到证据。三个常见误解要改掉：能站能走不等于没骨折；只用冷不用热，也不要冷热交替；扭伤不会「活动开就好了」，先歇着。骨头没长好之前别抽烟，见第 2 节第 1 条（戒烟）。别指望猛补钙、喝骨头汤让骨头长得快，见第 6 节第 30 条（骨折之后猛补钙）。老人跌倒后怀疑骨折的搬动禁忌见第 2 条。打了石膏或者卧床之后一条腿肿起来要警惕血栓，见第 11 条。治完之后要不要做伤残鉴定、要不要办残疾人证，见第 24 节第 9、10 条。

42. 被性侵之后，先到安全的地方打 110；验伤之前别洗澡、别洗衣服、别收拾房间，72 小时内去医院

- 成本：报警不花钱。紧急避孕药是非处方药，药店就能买。阻断药一个疗程上千元，要不要吃由医生判断，见本节第 38 条（72 小时内去拿阻断药）。难的是当时很难开口，也很想马上洗个澡。
- 说人话：身上、衣服上和屋里留下的痕迹，是指认对方最要紧的证据。所以验伤前尽量别洗澡，也别洗衣服、收拾房间，尽早打 110。紧急避孕药药店就有，越早吃越有效。72 小时内去医院，让医生判断要不要吃阻断药。
- 收益：北京市人民检察院的检察官说：「无论是未成年人还是成年人，遇到侵害，都应当第一时间拨打 110 报警」。及时报警、就医，「便于侦查机关及时勘查现场、提取物证痕迹、固定证据」。贵州省民政厅转载的人民日报防性侵手册写：「一旦不幸遭遇性侵害，最重要的事情就是留存证据」。要保留「体液、毛发、皮屑、通信记录等证据」，「被侵害后，不要擅自洗澡、洗衣物、收拾房间、扔东西」。熟人作案的，保留通话、通信记录。对方事后威胁或者收买，也要留下证据。北京市西城区人民检察院写的是：「在接受身体检查之前尽量不要洗澡」。世界卫生组织说，紧急避孕可以用在「女性在未采取有效的避孕保护措施时遭受性侵犯」的时候。建议在 5 天内用，越早越有效。含左炔诺孕酮（一种孕激素）的紧急避孕药，用过的女性怀孕率是 1.2% 到 2.1%。国内药店卖的左炔诺孕酮片是非处方药。武汉市卫健委的说法是：在无防护性生活后「72 小时以内，服药越早，预防妊娠效果越好」。艾滋病阻断药要尽可能 2 小时内吃上，最晚不超过 72 小时（全国）
- 证据等级：B
- 来源：北京市人民检察院 (2024). 法眼看剧 | 看《九部的检察官》 未成年人面对不法侵害该如何保护自己? (转载中央广播电视总台中国之声). <https://www.bjjc.gov.cn/c/bjoweb/mtbg1/75046.jhtml>; 贵州省民政厅 (2024). 未成年人防性侵手册，请家长孩子查收! (转载人民日报). <https://mzt>.

guizhou.gov.cn/xwzx/mzyw/202407/t20240723_85145012.html；北京市西城区人民检察院 (2018). 她们为什么不再沉默…… <https://www.bjjc.gov.cn/c/xicheng/xjjsl/320654084.jhtml>；世界卫生组织 (2021). 紧急避孕（实况报道）. <https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception>；武汉市卫生健康委员会 (2020). 安全合理使用紧急避孕药. https://wjw.wuhan.gov.cn/ztzl_28/fyjkkp/szjk/202010/t20201009_1461161.shtml；北京市人民政府. 事前、事后分不清？六问六答全面了解艾滋病病毒暴露前/暴露后预防. https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/jhsyfwzdzx/sjazbr/fakp/202311/t20231110_3299397.html

- 备注：给 B 是因为这些是官方的办案经验和用药建议，没有「照做之后定罪率高多少」的数字。受益人主要是你自己和家人。紧急避孕药的 72 小时是国内说明书的口径，世界卫生组织说 5 天内都有用，但越晚越差，别拖。已经怀孕的，紧急避孕药没有作用。报警时如实说，不隐瞒，也不夸大。对方事后找你私了、给钱或者威胁你，都留下记录，别删。想好了再报警也可以，但证据会随时间消失。不管报不报警，都要在时限内去医院。录音见第 8 节第 41 条（录音）。对方事后拿照片、拿报警来要挟你，同样是犯罪，见第 8 节第 32 条（对方拿报警、发照片来要钱）。朋友出了这种事，陪对方去报警、去医院，别先劝对方洗个澡休息一下。

43. 不满 1 岁的婴儿噎住哭不出声，趴着拍背 5 下、翻过来按胸口 5 下，轮着做，别按肚子

- 成本：不花钱。看一遍动作或者上一次婴儿急救课，几分钟到半天。难的是慌乱中先把孩子翻过来趴好。
- 说人话：孩子还能咳、能哭出声，就让他自己咳，你在旁边盯着。哭不出声、脸发紫，就让人打 120，你把孩子脸朝下趴在前臂上，用掌根在两块肩胛骨中间拍 5 下。没出来就翻过来，在胸口正中快速按 5 下，两样轮着做，别按肚子。孩子没反应了就改做心肺复苏。
- 收益：美国心脏协会和美国儿科学会出了 2025 年的儿童基础生命支持指南。指南写：窒息（比如异物堵住气道）「是婴儿和儿童的主要死因之一」。婴儿最常呛进去的是液体。还在咳、还能出声的是轻度，让孩子自己咳，同时盯着有没有变重。咳得很弱或者咳不出、哭不出、脸色发紫的是重度。重度要先叫急救，再「反复做 5 次拍背、接 5 次胸部冲击，直到异物出来或者婴儿失去反应」。指南不建议给婴儿做腹部冲击，因为可能伤到肚子里的脏器。胸部冲击现在推荐用一只手的掌根，因为它比原来的两指法按得更深。婴儿失去反应就开始心肺复苏，先按压，不摸脉搏。吹气前看得见的异物要取出来。指南明写「不要用手指盲目去掏」。国际红十字与红新月会联合会的 2025 年国际急救指南也是这一套。先在两肩胛骨之间用力拍最多 5 下，不行就把孩子翻过来按胸口最多 5 下，再不行马上叫急救。它按胸口用的是双手环抱、两个拇指按。福建省红十字应急救援培训中心说，1 岁以下婴儿要做「5 次背部拍击 + 5 次胸部冲击」。拍背时让婴儿俯卧在前臂上，头低于躯干
- 证据等级：B
- 来源：Joyner BL 等 (2025). Part 6: Pediatric Basic Life Support: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 152(suppl 2):S424–S447. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001370>, 全文见 <https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/pediatric-basic-life-support>；International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). *International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025*, 第 238–240 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>；福州市卫生健康委员会 (2026). 海姆立克急救法更新了. https://www.fuzhou.gov.cn/zgffzt/swjw/fzwj/jkkp/202601/t20260108_5268351.htm
- 备注：定 B 是因为支撑这套手法的主要是病例报告，没有「照做能少死多少人」的数字。收益定「大」是凭判断：完全堵住的气道几分钟内就会让孩子心跳停下。受益的几乎都是自家孩子。1 岁以上的孩子和成人改按肚子，见本节第 26 条（噎住拍背加腹部冲击）。按胸口用什么手法，各家写法不同。美国指南和国内红十字新版用一只手的掌根，国际红十字用两个拇指，老教程用两根手指。2025 年美国指南因为两指按不够深，已经不再推荐它。急救时用哪种都比不按强。东西咳出来了也

要去医院看，可能有碎块留在肺里。硬币、小玩具这类小东西放到孩子够不着的地方。孩子没反应之后怎么做，见本节第 44 条（婴儿心肺复苏）。

44. 不满 1 岁的婴儿没反应、没正常呼吸，开免提打 120，做婴儿心肺复苏：按 30 下吹 2 口气

- 成本：不花钱。婴儿心肺复苏要上课练一次，半天到一天。难的是对着孩子口鼻吹气，还有不敢用力按。
- 说人话：拍脚底没反应、没正常呼吸，就开免提打 120，手不停。双手环抱胸口用两个拇指按，抱不住就用一只手的掌根，按下去约 4 厘米，每秒约 2 下。每按 30 下，嘴包住孩子口鼻吹 2 口气。婴儿心跳停多半是喘不上气引起的，做了带吹气的心肺复苏，活下来的更多。
- 收益：美国心脏协会和美国儿科学会出了 2025 年的儿童基础生命支持指南。指南写：婴儿和儿童心跳骤停，主要原因仍是呼吸出了问题。在医院外心跳骤停的婴儿，活着出院的只有 6.6%。普通人遇到没反应、没正常呼吸、没有生命迹象的婴儿或儿童，「应当立即开始心肺复苏」，不要去摸脉搏。按压深度至少是胸廓前后径的三分之一，婴儿「约 1.5 英寸（4 厘米）」。频率每分钟 100 到 120 次。一个人做时，按 30 下吹 2 口气。两个人做时，按 15 下吹 2 口气。婴儿用一只手的掌根按，或者双手环抱、两个拇指按。环抱不住就用掌根。两根手指按的做法已经取消，因为按不够深。指南还写，院外心脏骤停的婴儿和儿童，按压之外再加吹气能提高存活。美国一个登记库统计了 3900 名 18 岁以下院外心脏骤停的孩子，59.4% 是婴儿。在场的人做了心肺复苏的，调整后活着出院的比例是 13.2%，没做的是 9.5%。调整后 OR 1.57（活下来的几率高约 57%），95% CI 1.25–1.96（可信范围）。在婴儿里，带吹气的心肺复苏和更高的存活有关，活下来的孩子脑子也恢复得更好。只按不吹的，结果和没人做差不多。国际红十字与红新月会联合会的 2025 年国际急救指南写：看婴儿有没有反应，要把孩子抱起来或者拍他的脚底。只有你一个人，就开免提自己打急救电话。手边没有能边按边打的电话，就先做 1 分钟心肺复苏再去打。首都儿科研究所有一篇科普，北京市卫健委转载了。它写：「如果只有 1 个人在场，先进行 2 分钟的心肺复苏后呼叫 120 救护车」。按压幅度「婴儿 4cm」。1 岁以内吹气要「口对口鼻」
- 证据等级：B
- 来源：Joyner BL 等 (2025). Part 6: Pediatric Basic Life Support: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 152(suppl 2):S424–S447. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001370>, 全文见 <https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/pediatric-basic-life-support>; Naim MY 等 (2017). Association of Bystander Cardiopulmonary Resuscitation With Overall and Neurologically Favorable Survival After Pediatric Out-of-Hospital Cardiac Arrest in the United States: A Report From the Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival Surveillance Registry. *JAMA Pediatrics* 171(2):133–141. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.3643>; International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025, 第 186–188 页. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>; 首都儿科研究所 (2022). 【儿研所儿医说】心肺复苏：爸妈必备的急救知识（北京市卫生健康委员会转载）. https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jksh/202210/t20221017_2837684.html; European Resuscitation Council (2025). ERC Guidelines 2025 for the lay public (Paediatric Basic Life Support 一章). https://www.erc.edu/media/p5ymaej/gl2025_layperson_book_ipdf-v11-e.pdf
- 备注：定 B 是因为存活的数字来自只跟踪记录的登记研究，而且算的是全体孩子，婴儿单独的数字摘要里没给。收益定「大」是按全体孩子的数字算的：活着出院从 9.5% 到 13.2%，相对多了约四成。受益的几乎都是自家孩子。和本节第 1 条（用力按压胸口）的区别有三点。一是婴儿要吹气，只按不吹对婴儿效果差。二是用两个拇指或一只掌根，按约 4 厘米，不用双手叠着压。三是一个入又没法边按边打电话时，先按再去打。先按多久各家不一：首都儿科研究所和美国指南的单人流程是 2 分钟，国际红十字是 1 分钟。手机开免提就没有这个问题。欧洲复苏委员会教的是先吹 5 口气再